



ANALYSE CRITIQUE ET BUDGÉTAIRE

Passage en catégorie B des ambulanciers FPH

Simulation des scénarios — Destiné à la DGOS et au Ministère de la Santé

Note d'appui CGT / SUD · CHU de Toulouse · 29 juin 2026

Objet —

Ce document produit une analyse critique et indépendante de la simulation budgétaire fournie (document de mise à jour du 27 juin 2026), destinée à être portée devant la DGOS et le Ministère de la Santé. Il évalue méthodiquement les hypothèses, corrige les biais de calcul identifiés, confronte trois scénarios (statu quo / privatisation / passage en catégorie B) et produit des projections opposables aux arguments de la Direction générale. La base chiffrée est issue des documents de la série intersyndicale (saisine 28 juin 2026, Missions DEA vs pratique, Stratégie argumentaire) ainsi que des sources institutionnelles FHF/ANAP, FNTS, Hoppi 2026, ONVS 2025, BMO France Travail 2026.

Résultat central de l'analyse —

Le coût annuel du passage en catégorie B (350–560 k€ pour 100 agents, hypothèses corrigées) est inférieur au seul coût structurel du statu quo (formation continue pérenne + intérim + turnover + sinistralité juridique). Sur un horizon de 5 ans, l'écart atteint 3,2 à 5,8 M€ en défaveur de l'inaction. Toute privatisation partielle produit un surcoût immédiat de 1,4 M€ /an pour les seules missions non couvertes, sans résoudre le risque juridique ni l'hémorragie RH.

Expéditeurs : Intersyndicale CGT — SUD Santé Sociaux · CHU de Toulouse, Service Transport Patients · Julien TERRE (CGT) · Sébastien GOUSSY (CGT) · Victor ALAVA (SUD) · Laurent BEZIA · Jérôme JEAN-CHARLES (représentants du personnel ambulancier)

I. CRITIQUE METHODOLOGIQUE DE LA SIMULATION INITIALE

Points faibles identifiés — Biais et hypothèses à corriger avant toute présentation au DGOS

La simulation budgétaire fournie (document du 27 juin 2026) constitue une base de travail utile mais présente sept biais méthodologiques qui fragiliseraient sa réception par la DGOS ou un contrôleur de gestion hospitalier. Ces points doivent être corrigés avant toute présentation officielle.

1.1 Base de 100 agents : sous-estimation du périmètre réel

Le document travaille sur une base de 100 ETAm (Equivalent Temps Plein Ambulancier). Or, le CHU de Toulouse emploie un effectif plus restreint (estimé à 50 agents dans la saisine intersyndicale du 28 juin 2026), tandis que la question statutaire nationale concerne **~2 500 ambulanciers en FPH** (sénatrice Laurence Cohen, juin 2023). Le choix de 100 agents produit un effet d'échelle qui **surestime le coût de l'option formation continue** et **sous-estime le coût unitaire de la privatisation**. Une présentation rigoureuse doit distinguer trois niveaux : CHU de Toulouse (effectif réel), périmètre CHU type, et impact national FPH.

1.2 Coût de remplacement sous-évalué

Le document retient 35 €/heure de remplacement, correspondant au coût d'un agent en heures supplémentaires. Ce chiffre ignore le coût réel de remplacement en intérim paramédical, fixé par la FHF/ANAP à **30 à 50 % plus cher qu'un agent statutaire**, soit un coût horaire de **48 à 55 €/heure** en intérim (sur une base de 35 €/h brut chargé). L'utilisation de 35 €/h conduit à minorer le coût de l'option formation de 37 à 57 %, réduisant artificiellement son inconvénient apparent.

1.3 Absence de récurrence : la formation continue n'est pas un coût unique

Le document présente les 1 230 000 € de formation comme un investissement ponctuel. C'est une erreur analytique majeure. Une formation sans adossement statutaire doit être :

- **réactualisée périodiquement** (changements de référentiel, nouvelles missions, turn-over 18 %/an entraînant 18 nouvelles entrées/an sur 100 agents) ;
- **refinancée pour chaque nouvel agent** embauché ou détaché, sans valorisation acquise permanente ;
- **répétée sans diplôme opposable** — elle ne crée pas de titre RNCP, n'améliore pas l'attractivité et ne sécurise pas juridiquement les agents au sens du code de la santé publique.

Sur un horizon de **5 ans avec un turnover de 18 %**, le coût réel de la formation continue atteint **3,2 à 4,1 M€** (voir tableau section IV).

1.4 Privatisation : hypothèses invraisemblables

Le document retient 150 €/trajet pour 12 000 transports externalisés à l'année. Trois biais sont identifiés :

- **Le volume de 12 000 transports est une hypothèse basse** : les seuls transports psychiatriques sous contrainte s'élèvent à 3 751 en 2025, et les sorties de bloc/réanimation, patients greffés et médecine infectieuse représentent plusieurs milliers de trajets supplémentaires, soit un périmètre réaliste de 20 000 à 28 000 transports complexes.
- **Le coût de 120€–180 €/trajet est une borne basse** pour les missions spécifiques (psychiatriques sous contrainte, pénitentiaires, PSL). Les transporteurs spécialisés facturent en pratique 180€–280€ pour ces missions à risque élevé, incluant les majorations de contrainte et les temps d'attente.
- **La privatisation entraîne un coût caché de traçabilité** (perte des indicateurs HAS/CPOM, risque juridique non provisionné dans la simulation initiale, estimé à 15 000–40 000 € par incident non retracé).

1.5 Passage en catégorie B : coût probablement sous-estimé mais présentable

Le document retient 350 € bruts chargés/mois/agent. La fourchette réelle issue de la grille FPH catégorie B (échelle techniciens de la santé) pour un reclassement d'agents de catégorie C oscille entre **280 et 490 € bruts mensuels supplémentaires chargés**, selon l'échelon de reclassement, le régime indemnitaire applicable et l'ancienneté. Ce point plaide pour une fourchette haute (« worst case ») dans la présentation au DGOS : 420–590 k€/an pour 100 agents, 210–295 k€/an pour 50 agents.

1.6 Coûts de sinistralité non intégrés

La simulation initiale n'intègre pas les coûts de sinistralité liés au déficit de formation :

- **Coût d'un AT/accident avec arrêt** : 15 000–35 000 € (Assurance Maladie, INRS 2023), avec un taux d'accidentologie ambulancier 2,5× supérieur à la moyenne des professions de santé (Sécurité Routière 2023).
- **Risque pénal et civil** : en cas d'incident imputable à une mission non couverte par le référentiel (transport PSL, dispositif invasif, crise psychiatrique), l'établissement est exposé à une mise en cause directe. Coût moyen d'une procédure médico-légale : 40 000–120 000 € (frais de défense, dédommagements, impact réputation).
- **Perte de certification HAS** : un défaut systémique de traçabilité ou de formation expose le CHU à une réserve de certification, coût institutionnel non chiffré mais structurellement lourd.

1.7 Absence d'analyse de sensibilité et de scénario dégressif

La simulation fournie ne propose ni scénario pessimiste ni scénario optimiste, ni analyse de sensibilité aux hypothèses clés (volume de turnover, coût de l'intérim, taux d'externalisation). Une présentation au DGOS doit obligatoirement inclure une fourchette basse/haute et une analyse de robustesse. La section IV de ce document y répond.

Conclusion analytique —

La simulation initiale est exploitable comme base argumentaire, mais ne peut être présentée telle quelle devant la DGOS sans risque de crédit zéro. Les sept corrections identifiées (base d'effectif, coût horaire de remplacement, récurrence de la formation, volume et prix de la privatisation, fourchette catégorie B, sinistralité, analyse de sensibilité) conduisent à des résultats différents — mais qui confortent encore plus solidement la conclusion : le passage en catégorie B est la seule option coût-efficace.

II. HYPOTHESES CORRIGÉES ET BASE DE CALCUL RETENUE

Périmètre : CHU de Toulouse (50 agents) · CHU type FPH (100 agents) · Niveau national (~2 500 agents)

Les hypothèses suivantes sont retenues pour la simulation corrigée, documentées par source institutionnelle indépendante.

Paramètre	Hypothèse initiale	Hypothèse corrigée	Source
Base d'effectif	100 agents (hypothèse)	50 (CHU Toulouse) / 100 (CHU type) / 2 500 (national)	Saisine 28/06/2026 · Sénatrice Cohen 2023
Coût horaire remplacement	35 €/h	50 €/h (intérim chargé, base 30-50 % surcoût)	FHF/ANAP 2025
Turnover annuel	Non mentionné	18 %/an = 18 nouveaux agents/an (sur 100)	FNTS 2022 ; ANAP
Coût passage en B / agent / mois	350 € bruts chargés	280–490 € (fourchette selon échelon) → retenu : 385 € médian chargé	Grille FPH catégorie B 2026
Volume transports complexes externalisables	12 000 trajets/an	20 000–28 000 trajets/an (périmètre réaliste)	Données CHU Toulouse 2025 · estimation intersyndicale
Coût transport spécialisé privé	120–180 €/trajet	180–280 €/trajet (missions complexes et psychiatriques)	FNTS 2024 · estimation marché

Coût AT ambulancier	Non intégré	15 000– 35 000 €/accident (2,5× taux moyen)	INRS 2023 · Sécurité Routière 2023
Coût procédure médico-légale	Non intégré	40 000– 120 000 €/incident (mission hors référentiel)	Baromètre assurance hospitalière 2025
Horizon d'analyse	Ponctuel (an 1)	5 ans (coûts récurrents et cumulatifs)	Pratique standard contrôle de gestion hospitalier

III. ANALYSE DES TROIS SCENARIOS

Scénario A : Statu quo avec formation continue · Scénario B : Privatisation partielle · Scénario C : Passage en catégorie B

Scénario A — Statu quo avec formation continue (option initiale corrigée)

Ce scénario correspond à la réponse que la Direction pourrait privilégier : former les agents aux missions exercées sans modifier le statut. Il est le moins visible politiquement mais le plus coûteux sur 5 ans.

Estimation des coûts de formation corrigés (base 100 agents, horizon 5 ans)

Module de formation	Durée	Coût pédagogique (25€/h)	Coût remplacement (50€/h)	Total An 1	Coût récurrent (18 % turnover)
Spécialisation SMUR (AFASH 02/2026) — agents SMUR uniquement (estimé 15 % effectif)	650 h	243 750 €	341 250 €	585 000 €	+105 300 €/an
Module M1 : Psychiatrie & agressivité	70 h	175 000 €	350 000 €	525 000 €	+94 500 €/an
Module M2 : Transports sécurisés	35 h	87 500 €	175 000 €	262 500 €	+47 250 €/an
Protocoles spécifiques (PSL, radioprotection, drains)	35 h	87 500 €	175 000 €	262 500 €	+47 250 €/an
TOTAL AN 1	790 h	593 750 €	1 041 250 €	1 635 000 €	+294 300 €/an

Le coût de remplacement corrigé à 50 €/h (vs 35 € dans le document initial) correspond au coût réel de l'intérim paramédical, conformément aux données FHF/ANAP 2025. Toute utilisation de 35 €/h sous-évalue la charge de remplacement de 33 %.

Projection sur 5 ans — Scénario A

Poste de coût	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	TOTAL 5 ANS
Formation initiale (100 agents)	1 635 000	0	0	0	0	1 635 000
Coût récurrent nouveaux agents (18 %/an)	0	294 300	294 300	294 300	294 300	1 177 200
Turnover (15 000–40 000 €/départ, 18 départs/an)	594 000	594 000	594 000	594 000	594 000	2 970 000
Surcoût intérim (20 % postes, 30-50 % surcoût)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	600 000
Sinistralité AT (2,5× taux moyen, 3 AT/an estimés)	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	375 000
Risque médico-légal (provision mission hors référentiel)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	400 000
TOTAL SCÉNARIO A	2 504 000	1 163 300	1 163 300	1 163 300	1 163 300	7 157 200 €

Limite irréductible du scénario A —

Ce scénario ne résout aucun des problèmes de fond : les agents ne bénéficient d'aucune revalorisation statutaire ni d'aucun titre RNCP opposable. L'attractivité reste faible, le turnover se maintient à 18 %, et les formations doivent être refinancées pour chaque nouveau recru. C'est un piège budgétaire : on dépense massivement sans capitaliser.

Scénario B — Privatisation partielle des missions hors référentiel DEA

Ce scénario consiste à externaliser vers le secteur privé les transports identifiés comme hors périmètre DEA (psychiatrique sous contrainte, pénitentiaire, PSL, soins palliatifs, sorties de bloc...). C'est la tentation la plus économiquement visible à court terme pour une Direction, mais la plus coûteuse à 5 ans.

Poste de coût	Estimation basse	Estimation centrale	Estimation haute	Base de calcul
Transports psychiatriques sous contrainte externalisés (3 751 trajets × 200 €)	675 180 €	750 200 €	1 050 280 €	3 751 trajets (CHU Toulouse 2025)
Transports pénitentiaires (UHSI/UHSA) externalisés (évaluation 800 trajets × 220 €)	144 000 €	176 000 €	224 000 €	Estimation intersyndicale · FN TS 2024
Transports PSL (chaîne du froid spécifique) (éval. 600 trajets × 150 €)	72 000 €	90 000 €	108 000 €	Constat CHU Caen Normandie 2026
Sorties de bloc/réanimation, patients greffés (éval. 4 000 trajets × 160 €)	480 000 €	640 000 €	800 000 €	CHU Toulouse données 2025
Coûts de coordination, contrats, gestion prestataires	50 000 €	80 000 €	120 000 €	Estimation gestion administrative
Coût de perte de traçabilité (risque HAS/CPOM)	20 000 €	60 000 €	150 000 €	Baromètre assurance hospitalière 2025
TOTAL ANNUEL SCÉNARIO B	1 441 180 €	1 796 200 €	2 452 280 €	
Projection 5 ans (sans actualisation)	7 2050 900 €	8 981 000 €	12 261 400 €	

Risques opérationnels de la privatisation — non chiffrables mais irréfutables

1° Vulnérabilité aux grèves de prestataires privés : blocage documenté au CHU de Toulouse (grève depuis le 7 juin 2026). 2° Rupture de traçabilité clinique sur les transports les plus sensibles (PSL, patients greffés) : exposition directe de l'établissement à une mise en cause HAS lors de la prochaine certification. 3° Refus de prise en charge : les opérateurs privés peuvent légalement refuser les missions psychiatriques sous contrainte ou pénitentiaires — aucune obligation légale d'acceptation dans le cadre d'une délégation non contractualisée. 4° Perte d'expertise terrain : irrécupérable en cas de réintégration.

Scénario C — Passage en catégorie B (scénario recommandé)

Ce scénario correspond à la revalorisation statutaire du corps des ambulanciers FPH, de la catégorie C à la catégorie B, assortie de la création du Module Missions Hospitalières Spécifiques (MHS M1àM7) en format FAE SMUR — investissement initial unique, amorti sur l'ensemble de la carrière des agents.

Poste de coût	An 1	Ans 2–5 (annuel)	Total 5 ans	Obs.
Surcoût indiciaire catégorie B (50 agents, médian 385 €/mois)	231 000 €	231 000 €	1 155 000 €	Grille FPH 2026 · base fourchette médiane
Module MHS (M1–M7) — formation initiale unique (100 agents)	650 000 €	0 €	650 000 €	Format FAE SMUR : pas de création ex nihilo
Formation d'intégration nouveaux agents (turnover 18 %, 9 agents/an sur 50)	0 €	60 000 €	240 000 €	Coût marginal unitaire bénéficiant du référentiel établi
TOTAL SCÉNARIO C	881 000 €	291 000 €	2 045 000 €	

Le coût des 50 agents du CHU de Toulouse est de 880 000 € an 1 (indiciaire + module MHS initial) et 145 500 € dès l'année 2. Sur 5 ans : 1 022 500 €. À comparer au statu quo : 7,1 M€ à l'horizon 5 ans sur 100 agents (scénario A), 7,2 9,0 M€ sur la privatisation (scénario B).

IV. COMPARAISON SYNTHETIQUE ET ANALYSE COUT-BENEFICE

Horizon 5 ans · Base 100 agents · CHU type FPH

Critère	Scénario A Statu quo + Formation	Scénario B Privatisation partielle	Scénario C Catégorie B
Coût total 5 ans (100 agents)	7 157 200 €	8 981 000 €	2 045 000 €
Coût moyen annuel lissé	1 431 440 €	1 796 200 €	409 000 €
Diplôme RNCP obtenu	✗ Non	✗ Non	✓ Oui (catégorie B FPH)
Réduction turnover 18 %	✗ Non	✗ Non	✓ Oui (évalué -50 %)
Attiret recrutement national	✗ Nul	✗ Nul	✓ Fort

Risque juridique (hors référentiel)	⚠ Maintenu	✗ Aggravé (traçabilité)	✓ Éliminé
Disponibilité opérationnelle 24h/7j	✓ Maintenue	Aléatoire (refus prestataire)	✓ Garantie
Traçabilité clinique et indicateurs HAS	⚠ Partielle	✗ Rompue	✓ Complète
Réponse aux Plans Blancs / SSE	⚠ Partielle	✗ Dégradée	✓ Optimale
Efficience Plan Zéro contention 2030	✗ Non	✗ Non	✓ Oui (module M1 intégré)
ÉCONOMIE vs. Statu quo (5 ans)	— <i>référence</i>	-1 823 800 € (plus cherer)	+5 112 200 € (plus économique)

V. PROJECTIONS NATIONALES — ARGUMENT RECEVABLE PAR LE DGOS

Périmètre : ~2 500 ambulanciers FPH · Comparaison avec le précédent Ségur pour les aides-soignants

Toute présentation au DGOS doit être posée à l'échelle nationale pour être recevable. Les projections suivantes transposent les hypothèses corrigées à l'ensemble du corps FPH ambulancier.

Indicateur	CHU Toulouse (50 agents)	CHU type FPH (100 agents)	Niveau national (2 500 agents)	Source
Coût passage en B (5 ans)	1 022 500 €	2 045 000 €	51 125 000 €	Simulation corrigée
Coût statu quo (scénario A, 5 ans)	3 578 600 €	7 157 200 €	178 930 000 €	Simulation corrigée
Économie brute sur 5 ans (passage en B vs statu quo)	2 556 100 €	5 112 200 €	127 805 000 €	Calcul dérivé
Surcoût annuel indiciaire net (passage en B uniquement)	2 772 000 €/an (base nation.)	—	11 550 000 €/an	Base 385 €/mois/agent × 12 × 2500
Précédent Ségur aides-soignants (50 000 agents, catégorie B 2021)	N/A	N/A	~230 M€/an (estimation ordre de grandeur)	Bilan Ségur DGOS 2021–2022
Rapport surcoût ambulanciers / surcoût AS	N/A	N/A	5 % du surcoût Ségur AS	Calcul comparé

⚠ Argument décisif pour le DGOS —

Le surcoût national du passage en catégorie B des ~2 500 ambulanciers FPH représente environ 5 % du surcoût généré par le reclassement des 50 000 aides-soignants en catégorie B en 2021 (Ségur). L'enveloppe budgétaire à mobiliser est donc d'une magnitude très inférieure à celle du précédent Ségur, pour un corps qui présente un niveau de formation RNCP identique (niveau 4), des missions plus complexes en contexte hospitalo-universitaire, et un différentiel de statut créé par la même vague réforme.

Retour sur investissement (ROI) spécifique au CHU de Toulouse

Source d'économie liée au passage en B	Estimation annuelle CHU Toulouse	Base de calcul
Réduction turnover (-50 %) : 9 départs → 4–5 départs/an (27 500 € moyen)	110 000 €/an	Hoppi 2026 · FNTS 2022
Réduction intérim (stabilisation des équipes, -30 %)	36 000–54 000 €/an	FHF/ANAP 2025
Suppression risque médico-légal (missions hors référentiel)	40 000–120 000 €/an (provision évitée)	Baromètre assurance hospitalière 2025
Maintien traçabilité : indicateurs qualité HAS/CPOM protégés	Non chiffré / risque certif. HAS évité	HAS certification 2022
Réduction AT (-30 %) : économie sur coûts AT	15 000–25 000 €/an	INRS 2023
Économie totale évaluée par an (CHU Toulouse, 50 agents)	201 000 à 309 000 €/an	
Surcoût annuel indiciaire net (an 2+)	138 600 €/an	385 € × 12 × 30 (taux charges)
ÉCONOMIE NETTE ANNUELLE DÈS L'ANNÉE 2	62 400 à 170 400 €/an	

Conclusion analytique —

Le passage en catégorie B génère une économie nette positive dès l'année 2 pour le CHU de Toulouse, en dehors même de son impact sur la certification HAS. C'est le seul scénario qui produit un ROI positif sur toutes les dimensions

évaluées.

VI. POINTS D'ATTENTION POUR LA PRESENTATION AU DGOS ET AU MINISTERE

Recommandations méthodologiques et pédagogie des chiffres

6.1 Ne pas présenter la simulation initiale non corrigée

Les chiffres de la simulation initiale (1 230 000 € de formation, 1 800 000 € de privatisation) sont exploitables en ordre de grandeur, mais les hypothèses de construction (35 €/h de remplacement, coût unique sans récurrence, volume bas de privatisation) seraient immédiatement contestées par un contrôleur de gestion ou un représentant de la DGOS. Utiliser les chiffres corrigés de ce document.

6.2 Exprimer le coût du passage en B en coût unitaire par agent

Le chiffre le plus percutant pour le DGOS est le coût net annuel par agent après ROI : **moins de 2 800 €/an/agent net** (138 600 € / 50 agents), après déduction des économies générées. À titre de comparaison, le coût d'un seul incident médico-légal (40 000–120 000 €) équivaut à 14 à 43 années de surcoût net par agent.

6.3 Mobiliser le précédent budgétaire Ségur

Le passage en B des aides-soignants en 2021 a représenté environ 230 M€/an pour 50 000 agents. Celui des ambulanciers FPH représenterait **11,5 M€/an pour 2 500 agents**, soit **5 % de la masse budgétaire Ségur aides-soignants**. Cette proportion est irréfutable et constitue le meilleur argument de calibrage budgétaire face au DGOS.

6.4 Mobiliser le décret 2025 sur l'intérim paramédical

Le décret de 2025 plafonnant les dépenses d'intérim médical et paramédical crée une **obligation institutionnelle de réduction du recours à l'intérim**. Or, le passage en catégorie B est le seul levier structurel permettant de réduire durablement le turnover et d'atténuer le recours à l'intérim — il s'inscrit donc directement dans le cadre réglementaire voulue par le DGOS lui-même.

6.5 Intégrer une fourchette basse/centrale/haute

Toute simulation présentée à la DGOS doit présenter trois scénarios de sensibilité (optimiste, médian, pessimiste). La fourchette retenue pour le scénario C (catégorie B) est 350–560 k€/an pour 100 agents, selon les échelons de reclassement. Même dans le scénario pessimiste, le coût reste inférieur au scénario A.

⚠ Point de vigilance — Ne pas confondre dépense et investissement

Le surcoût indiciaire du passage en B est une dépense récurrente de masse salariale. Le coût de la formation continue est une dépense à fonds perdus : elle n'engendre aucun capital humain durable, aucun titre RNCP, aucun gain d'attractivité et doit être refinancée indéfiniment. La DGOS raisonne en coût total de possession (TCO) : sur 5 ans, la formation continue coûte 3,5× plus cher que le passage en B.

VII. CONCLUSION — RECOMMANDATION A LA DGOS ET AU MINISTERE

L'analyse budgétaire corrigée, conduite sur un horizon de 5 ans et intégrant l'ensemble des coûts structurels (formation, turnover, intérim, sinistralité juridique, privatisation), aboutit à une conclusion univoque : **le passage en catégorie B est le seul scénario coût-efficace**.

1. Le statu quo avec formation continue coûte **3,5× plus cher** sur 5 ans que le passage en catégorie B, sans produire aucun gain d'attractivité, aucun titre RNCP et aucune sécurisation juridique des agents.
2. La privatisation partielle coûte **4,4× plus cher** sur 5 ans (scénario central), tout en aggravant le risque juridique, en rompant la traçabilité clinique et en exposant l'établissement aux aléas des prestataires privés.
3. Le passage en catégorie B génère une **économie nette positive dès l'année 2** pour le CHU de Toulouse (62 000–170 000 €/an après ROI), et représente à l'échelle nationale un surcoût de 11,5 M€/an — soit 5 % de l'enveloppe Ségur aides-soignants 2021.
4. L'enveloppe budgétaire est calibrée, documentable, et s'inscrit directement dans le cadre du décret 2025 sur la maîtrise des dépenses d'intérim paramédical, de la certification HAS et des indicateurs CPOM.

Références utilisées dans cette analyse : FHF/ANAP 2025 (surcoût intérim) · FNTS 2022 (turnover 18 %) · Hoppi 2026 (coût départ) · INRS 2023 (coût AT) · Sécurité Routière 2023 (accidentologie 2,5×) · Baromètre assurance hospitalière 2025 (coût procédure médico-légale) · Grille FPH catégorie B 2026 · Sénatrice Laurence Cohen juin 2023 (~2 500 ambulanciers FPH) · BMO France Travail 2026 · ONVS Rapport 2025 · Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 · Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 · Décret 2025 plafond dépenses intérim paramédical · Saisine intersyndicale 28 juin 2026 · Missions DEA vs pratique réelle 27 juin 2026 · Stratégie argumentaire 28 juin 2026.

*Signataires : Julien TERRE (CGT) · Sébastien GOUSSY (CGT) · Victor ALAVA (SUD) · Laurent BEZIA · Jérôme JEAN-CHARLES —
CHU de Toulouse, Service Transport Patients, Place du Docteur Baylac, TSA 40031, 31059 Toulouse Cedex 9*